ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

БЕНЦА Т. М.
професор кафедри терапії
ДЕНОВА Л. Д.
асистент кафедри терапії
Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
м. Київ, Україна

Проблема діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) у хворих на цукровий діабет 2-го типу (ЦД2) займає важливе місце у клініці внутрішніх хвороб. Пов'язано це з постійним збільшенням поширеності цих захворювань, а також із тим, що вони є однією з провідних причин інвалідизації і смертності пацієнтів [1, с.104].

Ураження бронхолегеневої системи у хворих на ЦД2 останнім часом привертає пильну увагу дослідників, оскільки легені – це орган з обширним мікроциркуляторним руслом, яке приймає участь у всіх видах обміну, у тому числі вуглеводному і ліпідному. Ускладнення, які виникають при ЦД, порушення в імунній системі, порушення мікроциркуляції, зниження дифузійної здатності легень, створюють передумови до хронічних запальних захворювань, у тому числі бронхолегеневої системи [4, с. 60].

За даними різних авторів, ЦД2 поєднується з ХОЗЛ у 2-16% хворих [8, с. 549]. У сучасних умовах ЦД розглядають як один із провідних факторів ризику важкого перебігу ХОЗЛ [4, с. 60]. За даними Шойхет Я.Н., у хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ЦД достовірно частіше виникають загострення більше 3 разів на рік – у 53,8% хворих у порівнянні з групою хворих на ХОЗЛ – 13,3% [6, с. 532].

ХОЗЛ – це неповне зворотнє обмеження прохідності дихальних шляхів, яке прогресує та асоціюється із незвичною запальною відповіддю легень на шкідливі частки або гази, головним чином у зв'язку із палінням, що проявляється продуктивним кашлем протягом 3 місяців упродовж двох років та збереженням у фазі ремісії ознак порушення вентиляції легень. Останнім часом ХОЗЛ розглядають як захворювання дихальних шляхів і легенів із системними проявами, до яких належать: зниження харчування, аж до кахексії; остеопороз; депресія; нормохромна анемія; дисфункція та атрофія скелетних м'язів, підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань [9].

У сучасних умовах для пояснення патогенезу загострення ХОЗЛ застосовується гіпотеза «порочного кола», яка пояснює взаємозв'язок між періодично нарастаючим «мікробним навантаженням» на дихальні шляхи і збільшенням клінічних проявів захворювання. Наявність ЦД2 у хворих з ХОЗЛ поглиблює несприятливий вплив бронхообструкції, порушує механізми адгезії, активації і апоптозу імунокомпетентних клітин і призводить до підвищеного мікробного навантаження бронхолегеневої системи грибами роду Candida, ентеробактеріями [7, с. 6].

ХОЗЛ, окрім пошкодження легень, викликає значні системні порушення, в основі яких лежить циркуляція цитокінів, активація клітин запалення [1, с. 105]. Участь імунної системи в розвитку запалення при ЦД підтверджена багатьма дослідниками (Ehrlich S.F. et al., 2010; Song Y. et al., 2007; Viardot A., 2010) [4].

Діагностичний алгоритм ХОЗЛ включає в себе виявлення факторів ризику розвитку захворювання: внутрішні – генетично зумовлені (спадковий дефіцит а1-антитрипсину), гіперреактивність бронхів, незавершений розвиток легень; зовнішні – тривале тютюнопаління (індекс тютюнопаління – 10-20 пачок/рік), інфекції, промислові та побутові шкідливі викиди в атмосферу, шкідливі звички, місцеве та загальне переохолодження, погані соціально-економічні умови [1, с. 106]. У клінічному обстеженні важливе місце займає виявлення характерних для ХОЗЛ скарг, а саме: хронічний кашель, що передує задишці, яка посилюється поступово впродовж років; спочатку виникає інколи, а з часом – турбує постійно, рідше вночі, мало– або непродуктивний кашель. Харкотиння зазвичай у невеликій кількості, після кашлю, слизове, може бути гнійним. Фізикальні ознаки: велика «діжкоподібна» грудна клітка, залучення в акт дихання допоміжної мускулатури, послаблення дихальних шумів, жорстке дихання або послаблене везикулярне, сухі свистячі хрипи під час дихальних рухів в спокої, вологі хрипи над всіма відділами легень з обох боків [9]. На фоні ЦД ХОЗЛ перебігає важче: більш виражені дихальна недостатність і хронічне легеневе серце, частіше виникають загострення.

Рекомендуються три рівні досліджень: 1) звичайне обстеження (спірометрія з аналізом кривих «потік-об'єм», проба з бронхолітиком, для визначення зворотності бронхіальної обструкції, рентгенографія органів грудної клітки (ОГК) для виключення інших причин обструкції бронхів, газовий склад крові); 2) для діагностики типу обструкції: спірометрія та пікфлоуметрія, досліджується бронхіальний опір, загальна ємність легень, бодіплетизмографія, гемоглобін, гематокрит, електрокардіографічне обстеження; 3) специфічна ідентифікація ознак та симптомів для кожного конкретного хворого [9]. За допомогою мультислайсової комп'ютерної томографії можна виявити ознаки специфічних змін легень при ХОЗЛ і ЦД2: розширення судин паренхіми, вогнищевоподібні тіні судинного генезу діаметром 2-5 мм, чоткоподібну форму судин. Також таким хворим рекомендовано обов'язково визначати середній тиск в легеневій артерії і легеневий судинний опір, так як часто спостерігається вторинна легенева гіпертензія, наявна легенева мікроангіопатія [6, с. 534].

Для визначення тактики ведення такого хворого беруть до уваги наявність загострення. Лабораторні критерії – це виявлення ознак запалення в периферійній крові та сироватці (а-1-глікопротеїн, а-1-антитрипсин, церулоплазмін, гаптоглобін, фібриноген), а також в харкотинні [1, с. 110]. В інструментальному обстеженні чільне місце займає дослідження функції зовнішнього дихання (ФЗД), за допомогою якого можна визначити тип (обструктивний, рестриктивний чи змішаний) та ступінь ЛН (I, II, III). Також проводяться проби з бронхолітиками та проба з фізичним навантаженням. Особливостями порушення ФЗД у хворих на ХОЗЛ із супутнім ЦД2 є невелика зворотність бронхіальної обструкції під впливом бронхолітика. Існує також зворотна залежність між ступенем легеневої недостатності та ступенем компенсації ЦД2 [2].

Рентгенографія ОГК та бронхоскопія використовуються для уточнення діагнозу, взяття бронхіального вмісту та прицільної біопсії. Бронхографія має допоміжне значення і застосовується рідко [3].

Наявність великої кількості патогенетичних механізмів у хворих з поєднанням ХОЗЛ і ЦД2 ускладнює перебіг і можливість терапії як ЦД, так і патології дихальної системи [5; 7].

Лікування ХОЗЛ довготривале, включає в себе модифікацію способу життя, а саме відмову від тютюнопаління, уникання впливу шкідливих викидів в атмосферу, нормалізацію режиму праці та відпочинку, харчування; медикаментозну терапію. Обов'язковою є санація хронічних вогнищ інфекцій та легенева реабілітація (за рекомендаціями Європейського респіраторного товариства, Британського та Американського торакальних товариств, Наказу МОЗ України № 499) [3; 9].

Найбільш часта причина загострення ХОЗЛ (біля 50% хворих) – це бактеріальна інфекція [5, с. 20]. Етіотропна антибактеріальна терапія призначається при загостренні ХОЗЛ I типу або II-III типів з гнійним харкотинням, симптомами інтоксикації та гіпертермією, та є емпіричною. Вибір здійснюється між 3 групами антибіотиків: макролідами, β-лактамами та фторхінолонами [3]. У хворих із супутньою патологією, зокрема ЦД2, препаратами вибору є захищений амінопеніцилін або таблетований цефалоспорин II-III покоління, сучасний макролід. Альтернативні препарати – респіраторні фторхінолони III-IV поколінь [3]. При поєднанні ХОЗЛ та ЦД2 антибактеріальні препарати бажано вводити парантерально [2].

Основою патогенетичної терапії ХОЗЛ є бронходилятатори (переважно інгаляційні агоністи бета2-адренорецепторів) та антихолінергічні лікарські засоби, а також метилксантини. Інгаляційні глюкокортикостероїди призначаються тільки в когорті хворих на важке ХОЗЛ (III-IV стадії) на тлі прийому бронходилятаторів [3; 9]. У хворих на ХОЗЛ на тлі ЦД доцільніше використовувати інгаляційні препарати через небулайзер [4, с. 64].

Поєднання ХОЗЛ та ЦД вимагає більшого об'єму фармакотерапії. Додатково до інгаляційних препаратів нерідко виникає потреба призначення глюкокортикостероїдів всередину та внутрішньовенно. Для лікування ускладнень та коморбідних захворювань у таких пацієнтів частіше застосовуються сечогінні та антигіпертензивні препарати [4, с. 64].

Загострення запального процесу, пов'язаного з ХОЗЛ, призводить до декомпенсації ЦД (аж до розвитку діабетичного кетоацидозу). Це вимагає збільшення дози таблетованих цукрознижуючих препаратів. При неможливості зниження глікемії на фоні призначення глюкокортикостероїдів хворих переводять на інсулінотерапію. [4, с. 65].

Симптоматичне лікування хворих на ХОЗЛ на тлі ЦД2 включає неінвазивну вентиляцію легень з інгаляцією кисню, призначенням фітонцидів, імуномодуляторів та ендобронхіальну терапію [1, с. 111].

Список використаних джерел:

1. Авдеев С.Н. Хроническая обструктивная болезнь легких как системное заболевание / С.Н. Авдеев // Пульмонология. – 2007. – № 2. – С. 104-112.
2. Березина Н.А. Клинико-функциональные особенности хронической обструктивной болезни легких, обусловленной вдыханием пневмотропных

поллютантов, у больных сахарным диабетом 2 типа / Н.А. Березина // Практическая медицина. – 2012. – № 6. – С. 25-27.
3. Клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальностю «Пульмонологія». Наказ МОЗ від 19.03.2007 № 128.
4. Особенности течения хронической обструктивной болезни легких у больных сахарным диабетом / Е.А. Титова, А.И. Алгазин, Т.А. Корнилова [и др.] // Пульмонология. – 2008. – № 5. – С. 60-65.
5. Радченко О.М. Оптимізація лікування загострення хронічного обструктивного захворювання легень / О.М. Радченко // Раціональна фармакотерапія. – 2012. – № 1(22). – С. 20-24.
6. Рентгенологические и допплерографические признаки поражения легких у больных сахарным диабетом / Я.Н. Шойхет, Е.А. Титова, В.К. Коновалов [и др.] // Казанский медицинский журнал. – 2007. – № 6(88). – С. 532-536.
7. Шмелев Е.И. Хроническая обструктивная болезнь легких и сопутствующие заболевания / Е.И. Шмелев // Пульмонология. – 2007. – № 2. – С. 5-9.
8. Comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease / W.M. Chatila, B.M. Thomashow, O.A. Minai [et al.] // Proc. Am. Thorac. Soc. – 2008. – Vol. 5. – P. 549-555.
9. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). NHLBI/WHO workshop report. – 2007. – Доступ: www.goldcopd.org.

РЕГУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ ФІТОТЕРАПІЇ ПРИ ПОРУШЕННІ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ

ГРЕСЬКО М. Д.
асистент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології
МАКАРЧУК В. А., ПАСІЧНИК Т. Р., ЧОРНЕЙ К. С.
студенти лікувального факультету
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

Проблеми жіночої частини населення планети є надзвичайно росповсюдженими. Сьогодні важко знайти дівчину чи жінку, яка не знайома з проблемами гінекологічної сфери. Водночас це можуть бути як запальні процеси, так і гормональні порушення, що в свою чергу можуть вилитись в більш серйозні проблеми, аніж порушення «місячних» (їх нерегулярність, болі перед, під час, чи після), проявляючись в формі мастопатій, фіброміом матки, чи інших важких «жіночих» проблемах. [1, с. 93-96].

Складна демографічна ситуація в Україні потребує приділяти більше уваги проблемі народження здорової дитини. Одним із факторів, які погіршують ці показники, є порушення менструальної функції. В останні роки зросла частота цієї патології. При цьому відсоток нез'ясованих причин є досить високим: від 20 до 35%. Однією з причин виникнення цієї проблеми можуть бути гормональні порушення. Фактори, що провокують гормональний дисбаланс,